

Рентгенологическая симптоматика осложнений у оперированных больных раком толстой кишки

Садыков М.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Асқынған тоқ ішек обырына операция жасалған науқастың рентгеносимптоматикасы

М.С.Садықов

Тоқ ішек обырына жасалған операциядан кейінгі ерте асқынуды дер мезгілінде анықтау, құрсақ қуысының өзгерісін дұрыс рентгенологиялық бағалауға байланысты.

Көкейкесті сөздер: тоқ ішек обыры, операциядан кейінгі асқыну, Рентген көрініс, КТ, операция.

Правильная рентгенологическая оценка изменений в брюшной полости, связанная с характером оперативного вмешательства имеет большое значение для своевременной диагностики ранних послеоперационных осложнений у оперированных больных с колоректальным раком.

Ключевые слова: колоректальный рак, послеоперационное осложнение, рентген картина, КТ, операция.

Для своевременной диагностики ранних послеоперационных осложнений у больных, оперированных по поводу опухолевых поражений ободочной и прямой кишки, большое значение имеет правильная оценка изменений в брюшной полости, связанных с характером оперативного вмешательства и особенностями обратного развития функциональных нарушений кишечника[1,3]. С этой целью проанализированы результаты рентгенологического, ультразвукового и КТ исследования у 112 больных. Все больные распределены по полу и возрасту одинаково.

Все послеоперационные осложнения у больных с колоректальным раком, целесообразно разделить на ранние и поздние. Наибольшее количество послеоперационных осложнений имели место в раннем послеоперационном периоде (16). Выявить эти осложнения, определить его характер, локализацию можно было лишь при комплексном рентгенодиагностическом и ультразвуковом обследовании. Следует заметить, что обследование начиналось с ультразвуковой диагностики, потом проводилось обычное рентгенологическое исследование, а в случаях необходимости, выполнялась компьютерная томография.

Соблюдение и выполнение вышеназначенного алгоритма обследования позволяло с наибольшей точностью выявить не только характер осложнения, но и его локализацию.

Основными осложнениями являлись несостоятельность швов кишечных анастомозов и инфицирование брюшной полости в процессе основной хирургической операции[2,4]. У 9 больных причиной раннего послеоперационного осложнения явилась ранняя спаечная кишечная непроходимость и у 12 – анастомозит. После тщательного анализа результатов клинко – лучевых обследований ряд больных (6, что составило 5,3 %), были подвергнуты ранним релапаротомиям, объем релапаротомий определялся интраоперационными находками.

Несомненный интерес представляет больные с поздними осложнениями после операций на ободочной кишке по поводу рака. Количество их меньше(5), чем осложнений

X-Ray Symptomatology Of Complications In The Surgical Patients With Cancer The Guts Fat

M.S.Sadykov

The correct radiological estimation of changes in the abdominal cavity, connected with the nature of operational interference has great significance for timely diagnostics of early postoperative complications in the postoperation patients with colorectal cancer.

The keywords: colorectal cancer, postoperative complication, X-ray are picture, CT, operation.

раннего периода.

Обследование больных, как указано выше, начинали с ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости, однако в раннем послеоперационном периоде (первые 3 – 5 дней) не всегда удается ее осуществить, так как в брюшной полости отмечается воздушность тонкого кишечника. Они выражались вздутием петель, причем, у ряда больных удавалось выявить отек кишечной стенки и складок слизистой. При этом учитывали состояние кишечника до оперативного вмешательства, наличие или отсутствие, давность тонко или толстокишечной непроходимости, локализацию патологического процесса в проксимальном и дистальном отделах толстой кишки. Эти данные имели чрезвычайно важное значение с клиническими проявлениями в определении показаний к выполнению релапаротомии.

Обращали внимание, что при локализации опухолевого процесса в проксимальном и дистальном отделах толстой кишки в первые 5 -7 сутки после операции, как правило, определялось вздутие единичных или множественных петель тонкого кишечника с утолщением ее стенок, а иногда и отеком складок слизистой (29 больных). Эти изменения обычно сохранялись до 7 – 8 суток после операции. Парез кишечника был отмечен нами на 5 – 9 сутки после основной операции. Причем, эти изменения отмечались не только клинически, но и при рентгенологическом и ультразвуковом обследовании.

Резко выраженное изменение тонкого кишечника представлено значительным скоплением газа и жидкого содержимого, с отеком кишечной стенки и расширением просвета кишечных петель более 6 см. Проводя рентгенологическое и ультразвуковые исследования брюшной полости в раннем послеоперационном периоде, необходимо знать вид и объем основного оперативного вмешательства: субтотальная колэктомия, колостомия, операции типа Гартмана, правосторонняя гемиколэктомия, обходные анастомозы и т.д. Знание новых послеоперационных взаимоотношений различных отделов кишечника дает возможность правильно интерпретировать распределение газа в его просвете, появление газа в забрюшинном пространстве, затемненные участки брюшной полости, как правило, в проекции колостомы.

Все вышеизложенное позволяет нацеливать клиницистов на возможные осложнения, что в свою очередь предопределяет сроки ранней релапаротомии.

Анализ нашего материала показал, что наиболее выра-

женные ультразвуковые и рентгенологические изменения брюшной полости были у больных, перенесших субтотальную колэктомию или правостороннюю гемиколэктомию с частью подвздошной кишки. Что касается рентгенологической семиотики, то нами отмечено отсутствие привычных анатомических ориентиров, необходимых для оценки состояния латеральных каналов брюшной полости, газа и плотного содержимого в оставшихся отделах толстой кишки. Так, после субтотальной колэктомии, выявляется жидкое содержимое в прямой кишке уже на 3 сутки после операции с появлением единичных горизонтальных уровней жидкости в тонком кишечнике (31 больных, 27,7 %). На 7 сутки после операции отмечалось перемещение петель тонкой кишки, содержащих газ в правую половину брюшной полости.

Очень важным, является выявление газа в забрюшинном пространстве, которое наблюдалось в первые 10 суток после операции (2 больных, 1,7 %). Этот симптом важен, если в течение 8 – 10 дней он не рассасывается. На рентгенологической симптом наличия газа в забрюшинном пространстве обращали особое внимание, если увеличение или его уменьшение вплоть до исчезновения газа в забрюшинном пространстве, как следствие развития патологического процесса.

Определяемые рентгенологически пузырьки газа в забрюшинном пространстве, которые имели четкие контуры, форму, размеры и определенное расположение вне зависимости от положения при исследовании больных (вертикальное, горизонтальное, латеропозиция), указывали на не воспалительный характер процесса в забрюшинном пространстве.

Как правило, при благоприятном течении послеоперационного периода газ в забрюшинном пространстве рассасывался на 7 – 9 сутки. Описанный рентгенологический признак, если он сохранялся более 9 – 10 суток и подтверждался данными УЗИ и КТ, указывал на наличие воспалительного процесса в забрюшинном пространстве и требовал безотлагательного проведения повторной операции с целью санации, как забрюшинного пространства, так и брюшной полости.

Такая ситуация возникла после правосторонней гемиколэктомии, наблюдалась всего 3 больных (3,7%), у которых полученные рентгенологические, ультразвуковые и данные компьютерной томографии были подтверждены при релапаротомии. При этом нужно отметить еще один важный рентгенологический симптом после операции на правой половине толстой кишки – это наличие небольших уровней

жидкости и газа в оставшейся части поперечно – ободочной, нисходящей и прямой кишке (28 больных - 25 %).

Несомненный интерес представляет рентгенологическая семиотика после оперативных вмешательств на левой половине ободочной кишки после ее резекции (операции Гартмана или его типа). При развивающемся «неблагополучии» в оставшейся части ободочной кишки рентгенологически выявлялось плотное содержимое с уровнем жидкости в ней (9 больных, 8,03%). Кроме того, определяется дополнительная тень овальной формы с четкими контурами, располагающаяся, как правило, в левой половине брюшной полости или левом подреберье – тень колостомы. В просвете самой оставшейся части ободочной кишки выявляется наличие содержимого в ней и газ.

Проведенные исследования показали, что при несложном течении послеоперационного периода при операциях на толстой кишке, функциональные изменения кишечника в ранние сроки после операции были отмечены у 44,3% больных, в то время как при осложненном течении послеоперационного периода этот процент достигал 72,5%.

Все это позволило прийти к выводу, что рентгенологическое исследование в раннем послеоперационном периоде у больных после операций на толстой кишке имеет не только диагностическое, но и прогностическое значение. Поэтому всем больным в послеоперационном периоде необходимо проводить рентгенологическое исследование органов брюшной полости и грудной клетки.

Литература

1. Абалин А.И., Жакова И.И., Туровский Б.М. «Стандартизованное рентгенологическое исследование в диагностике опухолей толстой кишки» // *Вестн. рентгенологии и радиологии* – 1992.-№, с.27-30.
2. Амелина О.П., Яновой В.В. «Несостоятельность колоректального анастомоза после реконструктивно-восстановительных операций» // *Пробл. проктологии*, 1985. №6, с. 118-123.
3. Араблинский В.М., Рудин Э.П., Мушников В.Н. «Состояние толстой кишки после операции Гартмана по данным рентгенологического исследования» // *Вестн. Рентгенологии*, 1985. №4, с. 28-32
4. Жакова И.И., Шумский В.И., Абалин А.И. и др. «Возможности рентгенологии в улучшении поликлинической диагностики онкологических заболеваний» // *Вестн. Рентгенологии и радиологии*, 1992. №3, с. 12-15.